

総

抗がん剤の分類:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・処方監査・連携のコツ

1 服薬指導で伝えるポイント



「なぜこの薬が効くのか」を分類に応じて一言添えると、患者さんの納得感・アドヒアランスが上がる



経口薬(分子標的薬・ホルモン剤)は飲み忘れ・自己中断のリスクが高いため、服薬状況を具体的に確認する



副作用の「出るタイミング」は分類によって異なることを伝え、いつ相談すべきかを具体的に示す

2 処方監査・疑義照会のタイミング

- ☐ 経口分子標的薬とCYP3A4阻害薬・誘導薬(アゾール系抗真菌薬、グレープフルーツ等)の併用がないか確認する
- ☐ 腎機能・肝機能に応じた減量基準が守られているか確認する
- ☐ 免疫チェックポイント阻害薬併用時は、ステロイド・免疫抑制薬との相互作用や既存の自己免疫疾患の有無を確認する
- ☐ ホルモン療法薬は骨密度・血栓症リスクに関する併用薬(エストロゲン製剤等)がないか確認する

3 施設間連携・情報共有のポイント



お薬手帳・診療情報提供書で、直近の治療レジメンと投与サイクル日を共有してもらう



irAE(免疫関連有害事象)は他科(皮膚科・内分泌科等)受診時も治療歴が伝わるようにする

4 実践チェックリスト

- ☐ 初回処方時に分類を確認し、その分類特有の重点モニタリング項目を薬歴に記載する
- ☐ 分類が切り替わるレジメン変更時は、新たな副作用プロファイルを患者さんに再度説明する
- ☐ 疑義照会の際は、分類特有の相互作用パターンを根拠として具体的に伝える

分類を意識した服薬指導・処方監査は、副作用の早期発見だけでなく、疑義照会の説得力にも直結する。